

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Ως Οξεία Αιμορραγία από το Κατώτερο Πεπτικό, καλείται κάθε επεισόδιο αιμορραγίας με εστία εντοπιζόμενη μετά τον σύνδεσμο του Treitz (*12δακτυλο-νηστιδικό όριο*), δηλαδή στο λεπτό έντερο, στο κόλον ή στον πρωκτό, που άρχισε τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Οι αιμορραγίες από τον κατώτερο πεπτικό σωλήνα αντιστοιχούν περίπου στο 20-30% του συνόλου των γαστρεντερικών αιμορραγιών, ενώ αποτελούν την κύρια αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο για 20-30 ασθενείς στους 100.000 κατ' έτος.

Οι οξείες αιμορραγίες από το κατώτερο πεπτικό σπανίως είναι απειλητικές για τη ζωή, παρά μόνο σε περιπτώσεις με παράγοντες κινδύνου ή συννοσηρότητα. Απειλητική για τη ζωή θεωρείται η αιμορραγία που εμφανίζει πτώση αιματοκρίτη (Hct) >20%, σφύξεις (HR) άνω των 100/λεπτό, ΣΑΠ < 110 mmHg, ανάγκη μετάγγισης πλέον των 2 μονάδων αίματος, αιμορραγία εμμένουσα άνω των 4 ωρών, προηγούμενη χρήση Ασπιρίνης, Κλοπιδογρέλης ή νεότερων αναστολέων της θρομβίνης (NOACs: *Xarelto, Pradaxa, Eliquis*) και συνύπαρξη τουλάχιστον άλλων δύο (2) παθολογικών, κυκλοφορικών ή μεταβολικών καταστάσεων.

Η πρόγνωση των περισσότερων οξείων κατωτέρων αιμορραγιών είναι σχετικά καλή, διότι πλείστες σταματούν αυτόματα και η θνητότητα είναι μικρότερη του 5%, εξαρτώμενη συνήθως από τη συνύπαρξη άλλων νοσηρών καταστάσεων στους ηλικιωμένους ασθενείς. Οι νοσηλείες είναι το 1/3 των αντίστοιχων για το ανώτερο πεπτικό και οι ασθενείς συνήθως είναι άρρενες ηλικιωμένοι με εκκολπωμάτωση, αγγειοδυσπλασίες, νεοπλάσματα, κ.ά.

Στην αιμορραγία του κατωτέρου πεπτικού σωλήνα ισχύουν τα ίδια - σε ό,τι αφορά στη θεραπευτική παρέμβαση - με την αιμορραγία του ανωτέρου πεπτικού.

Η αντιμετώπιση αρχίζει πάντοτε με τη διαφορική διάγνωση· λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τελικά η εστία της αιμορραγίας δεν ανευρίσκεται περίπου στο 25% των περιπτώσεων.

- ✓ Η αιμορραγία από χρόνια **εκκολπωματική νόσο** είναι η συχνότερη στον δυτικό κόσμο και προέρχεται από τη ρήξη τροφοφόρων αγγείων στο μίσχο του εκκολπώματος, ενώ επέρχεται κατά ώσεις και αυτόματα, υποτροπιάζει δε στο 15-35% των ασθενών.
- ✓ Η αιμορραγία από **τηλαγγειεκτασίες** είναι συχνή, προκαλούσα οξεία, χρόνια ή τυφλή απώλεια αίματος. Εμφανίζεται οπουδήποτε εντός του γαστρεντερικού σωλήνα, αλλά είναι συχνότερη στο δεξιό κόλον. Αφορά συνηθέστερα σε ηλικιωμένους, σπανίως σε νέους υγιείς. Είναι ανώδυνη αιμορραγία και μοιάζει με εκείνη των εκκολπωμάτων.
- ✓ Οι αιμορραγίες από **νεοπλάσματα** σπανίως είναι οξείες, συνήθως είναι τυφλές ή μικρές, διαλείπουσες κι ανώδυνες. Συνοδεύονται από προϊούσα αναιμία (συχνά *τυχαίο εύρημα*), καθώς και στένωση του αυλού του εντέρου και μείωση της διαμέτρου των κοπράνων.
- ✓ Αιμορραγίες **μετά πολυπεκτομή** είναι σπάνιες (0,5%), συχνότερες στους λαμβάνοντες αντιπηκτικά (κουμαρινικά, «ξαμπάνες») και όχι τόσο αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες.
- ✓ Οι **Αιμορροΐδες** προκαλούν το 5-10% των οξείων αιμορραγιών, με αποβολή ζωηρού ερυθρού αίματος, μόνο στο χαρτί ή πέριξ και όχι αναμεμιγμένου με τα κόπρανα. Διαγιγνώσκονται με ορθοσιγμοειδοσκόπηση, αλλά λόγω της συχνότητας αυτών, είναι δυνατόν η αιμορραγία να οφείλεται σε άλλη υψηλότερα ευρισκόμενη εστία (*νεόπλασμα πολύποδας*), που πρέπει να αποκλεισθεί έγκαιρα με τη διενέργεια κολονοσκόπησης.
- ✓ Σπάνια είναι η αιμορραγία από **εκκόλωμα Meckel** στον τελικό ειλεό, συχνή σε παιδιά ηλικίας 2-4 ετών, ενώ προκαλεί εικόνα οξείας σκωληκοειδίτιδας σε παιδιά 5-12 ετών.
- ✓ Αιμορραγία από διάφορα **είδη κολίτιδος** εμφανίζεται με εξέλκωση και φλεγμονή και πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί η αιτία της κολίτιδος: ελκώδης, αιμορραγική ή Crohn, λοιμώδης (*Salmonella, Shigella, τοξικό στέλεχος E.coli O157:H7, Campylobacter, CMV, παράσιτα*), ψευδομεμβρανώδης (*Clostridium difficile*) μετακτινική, ισχαιμική, κ.ά. Συνοδεύεται από έντονα κοιλιακά άλγη, ευαισθησία και λευκοκυττάρωση που σπανίως είναι μεγάλη. Απαιτείται βιοψία, ιστολογική εξέταση και ενίοτε καλλιέργεια κοπράνων, μαζί με την κατάλληλη αγωγή, για την τελική θεραπευτική αντιμετώπιση.